

Не ставьте себе диагноз

Определить заболевание может только врач.

[Онлайн-консультация с врачом](#)

Гепатит С - симптомы и лечение

Что такое гепатит С? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 18 лет.

Дата публикации 16 октября 2017 г.

Обновлено 29 июня 2026 г.

Авторы



Александров Павел Андреевич

Инфекционист, стаж 18 лет

Литературный редактор: Елена Бережная

Научный редактор: Сергей Федосов

Шеф-редактор: Лада Родчанина

Содержание

[Определение болезни. Причины заболевания](#)

[Симптомы гепатита С](#)

[Патогенез гепатита С](#)

[Классификация и стадии развития гепатита С](#)

[Осложнения гепатита С](#)

[Диагностика гепатита С](#)

[Лечение гепатита С](#)

[Прогноз. Профилактика](#)

[Источники](#)

[Клинические случаи](#)

Определение болезни. Причины заболевания

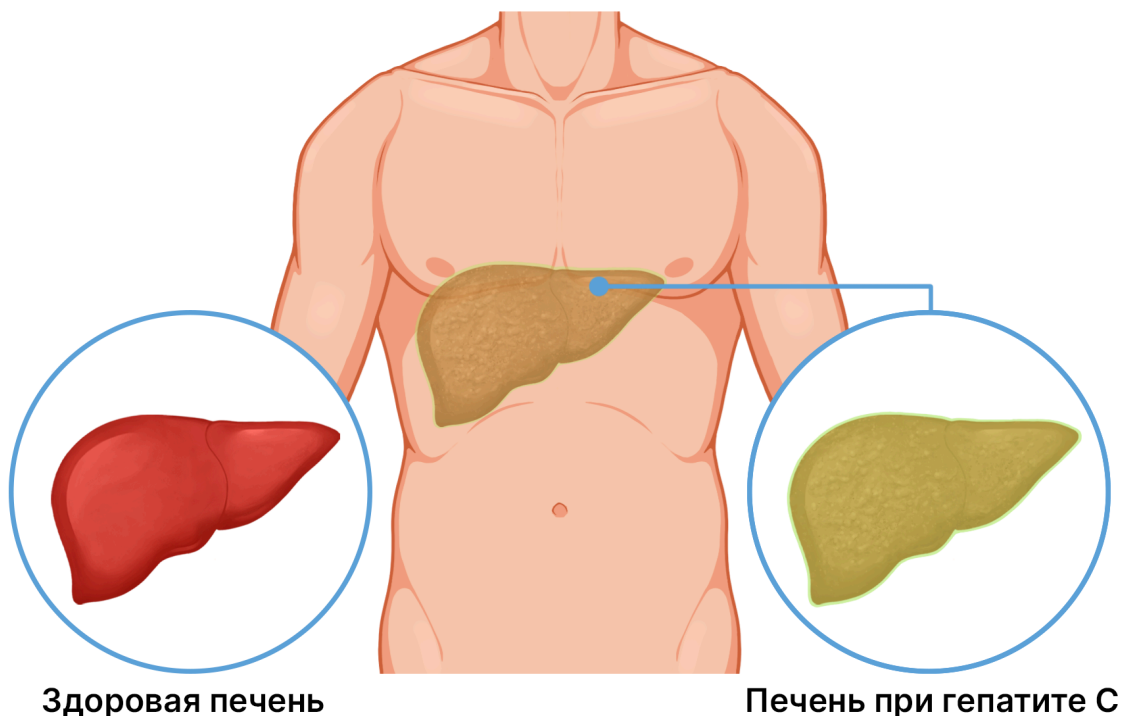
Вирусный гепатит С — острое или хроническое инфекционное заболевание, вызываемое различными типами вируса гепатита С, которые поражают в основном гепатоциты (клетки печени) и вызывают развитие воспалительного процесса в печени. При сочетании ряда факторов, образа жизни и отсутствии адекватного лечения вирусы гепатита С приводят к [цирротической перестройке ткани](#) и [раку печени](#) (гепатоцеллюлярной карциноме).

[Краткое содержание статьи — в видео:](#)

Этиологический агент — вирус гепатита С (ВГС). Вирус был впервые выделен американскими учёными в 1989 году.

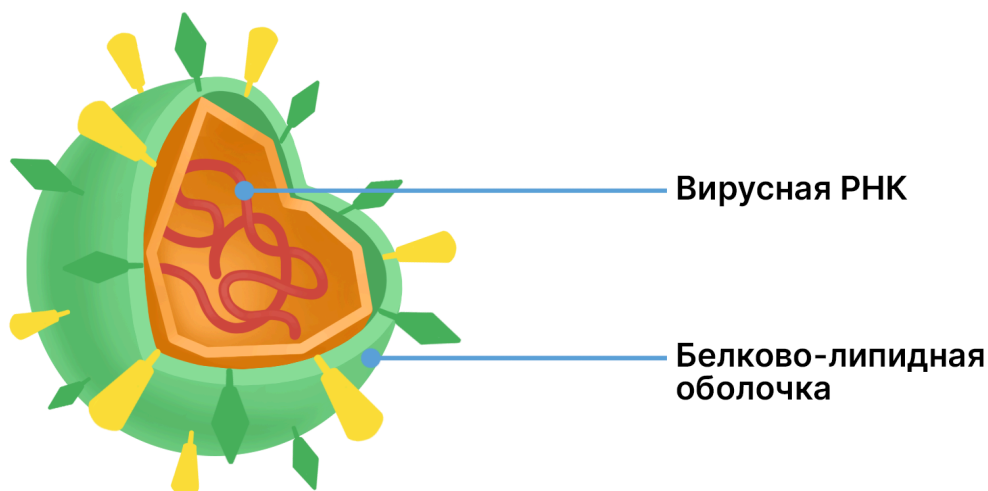
Таксономическая структура:

- царство — вирусы
- семейство — Flaviviridae
- род — Hepacivirus
- вид — вирус гепатита С (hepatitis C virus, HCV) — 7 генотипов и 67 подтипов



Здоровая печень

Печень при гепатите С



© ПроБолезни. Все права защищены

Гепатит С

Этиологические и морфологические свойства вируса

Диаметр вириона (вирусной частицы) — 50 нанометров. Имеет внешнюю белково-липидную оболочку. Оболочка вирусной частицы образуется в том числе за счёт взаимодействия вируса с липопротеидами низкой плотности хозяина, что позволяет ему ускользать из под иммунной атаки и проникать в клетки.

Генетическая структура представляет собой линейную однонитевую молекулу рибонуклеиновой кислоты (РНК), её размер примерно 9400 нуклеотидов. В ней выделяют следующие зоны: шифрующие структурные (Е1 и Е2 белки) и неструктурные (функциональные) белки — NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B, отвечающие за различные функции в жизни вируса. Структурные белки определяют прямой цитопатический эффект (повреждение клеток), полиморфизм (многообразие) вируса, участвуют в эффекте проникновения и выхода из клетки. Неструктурные белки участвуют в процессе развития и размножения вируса, определяют развитие резистентности (устойчивости) к интерферонам (NS5A). Встраивания вирусной РНК в геном клеток человека не замечено.

Вирус неоднороден (есть его различные подвиды — генотипы). Это обусловлено тем, что скорость его репликации огромна (за сутки 10^{11} - 10^{12}) и в результате возникает большое число

ошибок — вирус быстро мутирует. Такие мутации позволяют вирусу ускользать от иммунного ответа человека и длительно находиться в организме, а также сопротивляться воздействию лекарственных препаратов. Основным резервуаром вируса — это клетки печени, однако он способен размножаться и в клетках иммунной системы (макрофагах, моноцитах и др.).

В целом вирус малоустойчив в окружающей среде. Под воздействием хлороформа, спирта, [хлоргексидина](#) и других дезинфицирующих средств погибает практически мгновенно, инактивируется при температуре 100 °C за 2 минуты, при температуре 60 °C за 30 минут. При комнатной температуре живёт не более четырёх суток, под действием ультрафиолета погибает за 30 минут. В плазме, эритроцитарной массе и др. может сохраняться до года. На культурах клеток не культивируется, не имеет гемагглютинирующей (склеивающей эритроциты) и гемолитической (разрушающей эритроциты) активности [\[2\]\[8\]\[10\]\[11\]](#).

Передача вируса гепатита С

Передача вируса осуществляется только через кровь. Инфицирующая доза в несколько десятков раз больше, чем при гепатите В, т. е. для заражения нужны видимые следы крови. А вот пути заражения бывают различны:

- употребление наркотиков;
- медицинские манипуляции (в том числе пирсинг, тату и др.);
- половой путь (незащищённый половой контакт, в среднем около 1,5 % в гетеросексуальной семье);
- от матери к ребёнку в родах;
- бытовой путь (использование общих бритв, ножниц, зубных щёток).

При поцелуях, рукопожатиях, через посуду, сухие пятна крови на одежде, через воду, при кашле, чихании, потении, сидении рядом, по воздуху и т. д. гепатит С не передаётся. Заразиться через грудное молоко также нельзя, но заражение возможно при попадании крови матери на повреждённые губы ребёнка. Есть незначительный риск при попадании инфицированной крови в глаза, однако это единичные случаи. Заразиться при переливании крови практически невозможно, т. к. кровь на гепатит С тестируют методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) с высокой чувствительностью.

Нет никаких научных оснований ограничивать выбор профессии, работы и круг общения людей с гепатитом С — передача осуществляется только через кровь, поэтому ограничений в работе (например учителем, врачом, няней), контактах с родственниками и т. п. быть не должно.

Территориальное распределение

Гепатит С распространён во всем мире. Наиболее часто он встречается в Регионе ВОЗ Восточного Средиземноморья и Европейском регионе ВОЗ, где в 2015 г. распространённость HCV, по оценкам, составила соответственно 2,3% и 1,5%. Общее количество больных вирусным гепатитом С в мире не менее 150 млн, в Российской Федерации — неизвестно (по некоторым данным ориентировочное количество больных — не менее 2 млн человек). По состоянию на 2016 год в США было заражено не менее 2,4 млн человек (по другим данным — не менее 4 млн). По самым скромным подсчётам в этой стране в 2018 году от гепатита С умерли не менее 15 тыс. человек. В РФ преобладающее распространение имеют генотипы 1b и 3a, но частота их выявления может значительно колебаться в зависимости от региона [\[4\]\[7\]\[9\]](#).

В настоящее время вирусный гепатит С распространяется в общей популяции, т. е. заболеванию подвержены люди всех возрастов и социальных слоёв, однако наибольший риск имеют следующие категории:

- потребители инъекционных наркотиков;
- ВИЧ-инфицированные;

- пациенты отделений гемодиализа;
- лица, подвергшиеся трансплантации органов (в настоящее время менее значимо);
- медработники;
- дети, рождённые от матерей с гепатитом С;
- маргинальные слои общества, работники секс-индустрии.

После перенесённого острого вирусного гепатита С примерно 30 % людей самоизлечиваются, т. е. полностью избавляются от вируса, в остальных случаях формируется хронический гепатит. Предикторы (прогностические параметры) самоизлечения — желтуха, высокий уровень АЛТ, молодой возраст, женский пол, 1 генотип вируса, наличие **гепатита В** с HbsAg (антигеном вируса гепатита В). У каждого 5–25 человека из 100 в течение 10–20 лет от момента инфицирования при хронизации развивается цирроз печени и у них имеется 1–4 % годовой вероятности развития рака печени.

Провоцирующие факторы развития цирроза печени:

- мужской пол;
- возраст более 50 лет;
- злоупотребление алкоголем;
- коинфекция **ВИЧ**, гепатита В или стеатогепатита;
- иммуносупрессивная терапия.

Гепатитом С можно заразиться после выздоровления от предыдущего случая (даже тем же генотипом), можно заразиться другим генотипом, даже если человек уже имеет гепатит С какого-либо генотипа (суперинфекция). В этом случае наблюдается борьба между генотипами за доминирование. Побеждает, как правило, какой-то один, а другой может сохраняться на минимальных степенях репликации. При этом существует риск ошибки при определении генотипа.

Иммуногенность вируса слабая, т. е. антитела, которые должны вырабатываться в ответ на заражение, появляются медленно (не ранее чем через 3 недели от заражения) и не обладают явным вируснейтрализующим действием [\[2\]](#)[\[4\]](#)[\[8\]](#)[\[9\]](#).

Симптомы гепатита С

Если у вас есть похожие симптомы, обратитесь к инфекционисту онлайн

Он даст развёрнутые рекомендации. Заниматься самолечением опасно.



Скрытый (инкубационный) период гепатита С может составлять от 2 недель до 6 месяцев. В это время может не быть никаких признаков заражения и развивающегося заболевания. Однако коварство гепатита С в том, что даже по прошествии этого времени может не возникнуть никаких явных симптомов и проявлений (большинство больных вообще не имеет симптомов или их нельзя связать с гепатитом). Даже если симптомы и возникают, то зачастую они настолько незначительны, что человек абсолютно не придаёт им значения и не обращается за медицинской помощью до развития осложнений. Чаще всего информация о болезни появляется после прохождения рутинных исследований для операции или донорства крови.

Симптомы вирусного гепатита С в остром и хроническом периоде:

- снижение или отсутствие аппетита;
- общая слабость, ухудшение самочувствия, повышенная утомляемость, [депрессия](#) (один из основных симптомов);
- тошнота;
- тяжесть и дискомфорт в правом подреберье;
- боли в животе, небольшое расстройство пищеварения;
- боли в суставах;
- в редких случаях — пожелтение склер глаз, кожи, потемнение мочи или осветление кала.

Повышение температуры отмечается редко. Возможен различный характер течения хронического заболевания, в большинстве случаев на протяжении десятков лет больной испытывает незначительную усталость, периодический дискомфорт в правом подреберье, иногда связанный с погрешностями в диете. Примечательно, что чёткого продолжительного периода ухудшения самочувствия обычно нет. Лишь на завершающей стадии заболевания (через несколько десятков лет) человек испытывает резкое ухудшение самочувствия, нарастание отёков, в том числе у него наблюдается накопление жидкости в брюшной полости (асцит), повышенная кровоточивость, похудание, желтуха. Зачастую толчком к этому служит принятие алкоголя на праздники в значительных дозах. В этом коварство вирусного гепатита С — мнимый период благополучия даже при высокоактивном инфекционном процессе ("ласковый убийца", как длительное время его называли).



Изменение цвета кожи при гепатите С [14]

Гепатит С у беременных

Каких-либо значимых различий в течении вирусного гепатита С при беременности нет, как правило, происходит даже минимизация клинических и лабораторных изменений. Риск заражения ребёнка имеется лишь в родах, причём чем выше количество вируса в мл крови (вирусная нагрузка), тем выше риск. Выбор способа родоразрешения может влиять на риск передачи вируса при высокой вирусной нагрузке (свыше 8×10^5 МЕ/мл): при естественных родах риск до 8 %, при плановом кесаревом сечении — до 1 % (некоторые исследователи не подтверждают это). При коинфекции ВИЧ у матери риск передачи значительно возрастает — до 15 %.

Гепатит С у детей

После рождения от матерей с гепатитом С у 100 % детей выявляются материнские антитела к вирусу до 18 месяцев в максимальном исчислении (это нормально). Если заражения не произошло, в течение этого срока антитела исчезают и у ребёнка больше не будет никаких следов контакта. Если происходит заражение, то уже через 1-2 месяца в крови будет выявляться вирусная РНК в ПЦР исследовании (требует повторения даже при первичном отрицательном результате). Как правило, течение гепатита у детей малоактивное и не приводит к выраженным изменениям печени и самочувствия до момента возможного современного лечения и выражается только периодическим повышением АЛТ/АСТ [2][3][8][9].

Патогенез гепатита С

Проникая в организм, вирус гепатита С не оставляет никаких следов в месте внедрения. С током крови он быстро попадает в клетки печени, где оказывает неярко выраженное прямое разрушающее действие на клетки-мишени и в большей степени вызывает иммуноопосредованное поражение клеток на фоне репликации вируса. При использовании

одного из исследований — ультрачувствительного ПЦР (полимеразной цепной реакции) — РНК вируса в крови может обнаруживаться уже через 2 недели от момента заражения. Значений, которые выявляются всеми тест-системами, как правило, вирусная нагрузка достигает через 1,5 месяца после заражения.

Нарушается баланс продукции цитокинов (белков, которые оказывают комплексное регулирующее влияние на воспаление и иммунитет):

- усиливается выработка интерлейкинов IL-4 и IL-10 (сигнальных веществ, которые вырабатываются клетками иммунной системы и служат для регуляции активности других клеток);
- снижается образование интерферонов IL-2 (белков с противовирусной и иммуномодулирующей активностью);
- подавляется активация CD4+ лимфоцитов (клеток, которые отражают работу иммунной системы).

Возможность нахождения и размножения вируса в клетках иммунной и нервной систем делает его недоступным для иммунного контроля. Главенствующая частота перехода вирусного гепатита С в хроническую форму (около 70 %) обусловлена не только различными особенностями самого вируса, но и обязательным участием (или вернее неадекватным участием) иммунной системы:

- наличием внепечёночного размножения вируса (главным образом в моноцитарной системе);
- наличием множества генотипов с подтипами и частыми мутациями (перестановками составляющих генома вируса);
- запуском иммунопатологических реакций, которые участвуют и во внепечёночных поражениях при гепатите С, в том числе в клетках эндотелия сосудов головного мозга;
- низкой иммуногенностью вируса;
- участием в патогенезе процессов перекисного окисления липидов.

После заражения и малосимптомного протекания острой фазы заболевания при отсутствии самоизлечения (около 30 %) наступает хронизация инфекции — длительный латентный период (до 10-30 лет, иногда более длительно). В течение этого периода человек ведёт обычный образ жизни, не испытывает никаких явных признаков заболевания, а появляющееся чувство усталости вполне логично списывает на интенсивный современный ритм жизни.

Длительность латентного периода зависит от свойств вируса, его реактивности, развития иммунопатологических реакций иммунной системы, образа жизни человека и других факторов. Однако рано или поздно наступает переломный момент в системе взаимодействия патогенного микроорганизма и восприимчивого человеческого макроорганизма. Несмотря на широкие регенераторные возможности печени происходит нарушение её восстановительных сил. Вследствие постоянного некупируемого воспалительного процесса активная функциональная ткань печени замещается жировой и далее соединительной тканью (рубцовой). При этом нарушается нормальное функционирование органа и по механизму обратной связи происходит прогрессирующее ухудшение работы печени и жизнедеятельности организма в целом [\[2\]](#)[\[4\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#).

Классификация и стадии развития гепатита С

Острый вирусный гепатит С

Периоды:

1. Инкубационный период — от 3 недель до 4-6 месяцев. Полное отсутствие симптоматики.

2. Преджелтушный (продромальный) период — от 4 суток до 3 недель. Симптомы малозаметны, может быть депрессивное настроение, слабость, дискомфорт в животе, неустойчивый стул.
3. Период паренхиматозного гепатита (желтушный) — от 1 до 3 недель. Бывает редко, чаще отмечается незначительное желтушное окрашивание склер в совокупности с предыдущими признаками.
4. Период выздоровления (реконвалесценции) или переход в малоактивное хроническое течение — от 3 до 6 месяцев.

По (МКБ-10): B17.1 Острый гепатит С.

По клинической форме:

1. Манифестная:
 - а. желтушная (типичная);
 - б. безжелтушная.
2. Бессимптомная:
 - с. субклиническая (симптомы выражены очень слабо);
 - д. инаппарантная (симптомов нет, возможны лишь лабораторные изменения).

По степени тяжести:

- Лёгкая — незначительная интоксикация до 5 дней, отсутствие или незначительная желтушность до 7 дней, отсутствие лихорадки, нормальные или незначительно увеличенные размеры печени, общий билирубин до 85-100 мкмоль/л, протромбиновый индекс (ПТИ) до 80 %, АЛТ до 500 ед/л.
- Средней тяжести — умеренная интоксикация до 7 дней, умеренная желтушность до 10 дней, субфебрилитет (повышение температуры тела в пределах от 37,1 до 38,0 °С) в начальном периоде до 5 дней, увеличение печени до 4 см, общий билирубин 100-170 мкмоль/л, ПТИ 80-60 %, АЛТ до 1000 ед/л.
- Тяжёлая — резко выраженная интоксикация 15 и более дней, интенсивная желтушность кожи 3 недели и более, фебрильная температура весь начальный и период разгара болезни, **тахикардия**, увеличение печени на 6 см и резкое её уменьшение в размерах на фоне прогресса болезни, общий билирубин от 170 мкмоль/л, ПТИ менее 60 %, АЛТ более 1000 ед/л.

По длительности течения:

- острый гепатит С (циклический — до 3 месяцев, острый затяжной — 3-6 месяцев);
- хронический гепатит С — продолжительностью более 6 месяцев.

Классификации хронических форм не разработаны, могут применяться различные составляющие на основании выраженности цитолитического синдрома, уровня повышения печёночных ферментов, морфологических изменений печени, наличию осложнений и др. [2][10][11].

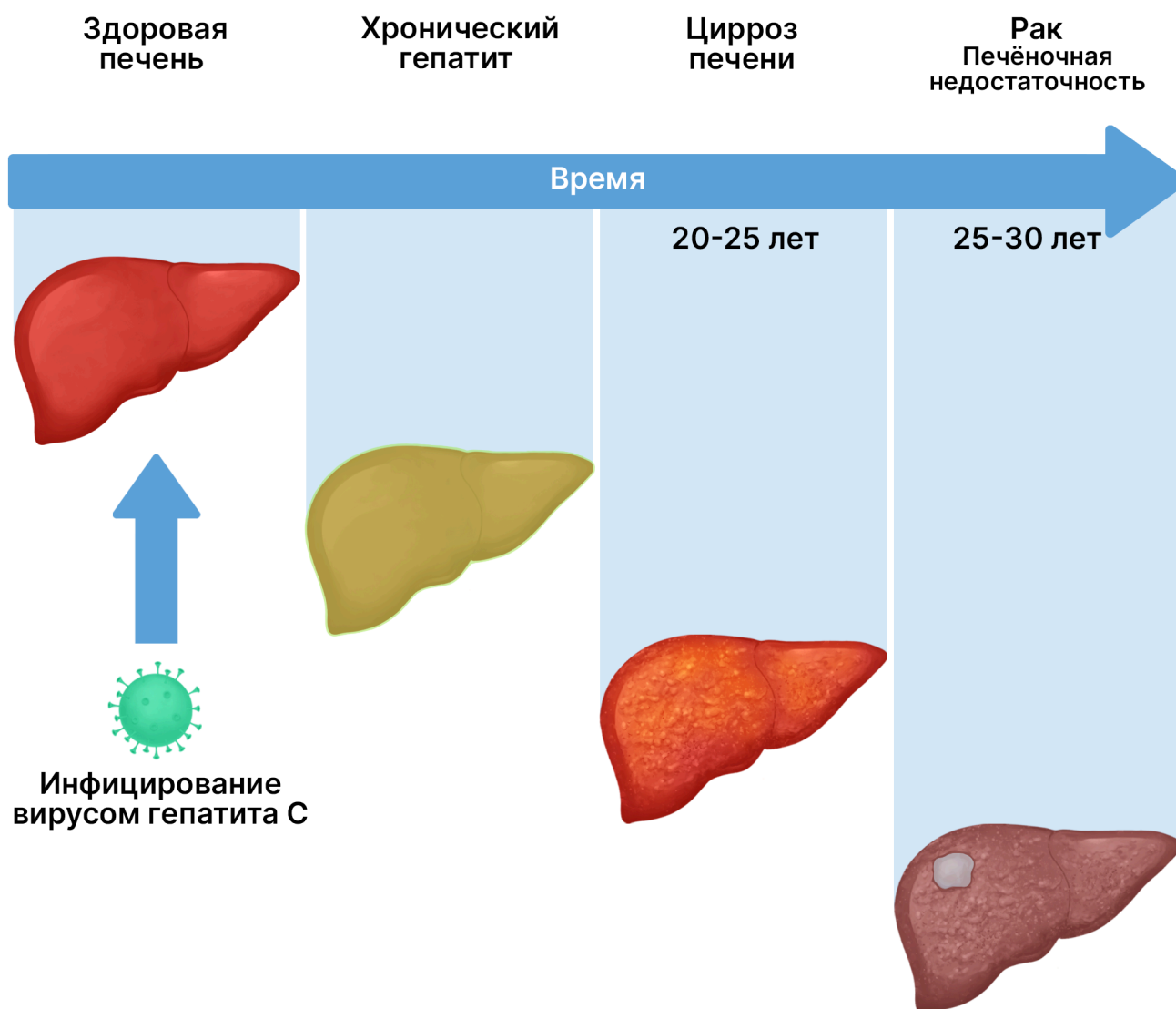
Осложнения гепатита С

В остром периоде гепатита С возможно развитие "печёночной комы" — резкого выраженного угнетения функции печени вследствие массивной гибели печёночных клеток и накопления в организме токсичных продуктов обмена различных веществ. Это состояние характеризуется заторможенностью, потерей сознания, нарушением витальных (жизненно важных) функций. Однако встречаемость данного осложнения крайне низкая.

В хронической фазе болезни (или, по мнению части исследователей, конечной фазе заболевания) наиболее частым осложнением является развитие **цирроза печени** — замещения функционального долькового строения печёночной ткани грубым соединительнотканым

образованием, что приводит к неадекватному функционированию органа. Определённое время печень способна выполнять функцию даже на стадии цирроза, но со временем при воздействии вируса наступает декомпенсация работы. Это состояние характеризуется нарушением кровотока в печени, повышением давления в системе воротной вены, расширением вен пищевода и желудка, увеличением селезёночной вены. Прогрессивно снижается уровень выработки белков, факторов свёртывания крови, фильтрационная способность. Появляются отёки, асцит (скопление жидкости в брюшной полости), кровотечения различной интенсивности, ухудшается общее состояние, интеллектуально-мнестические характеристики. В конечном итоге возможен летальный исход из-за массивного кровотечения и полиорганной недостаточности.

Не менее значимое осложнение хронической фазы гепатита С — развитие **гепатоцеллюлярной карциномы** (опухолевое перерождение). Согласно основной гипотезе, злокачественное перерождение возникает в результате повышенного распада клеток печени и последующего их восстановления, что приводит к повышенному числу мутаций. На ранних стадиях принципиальных отличий от течения хронического гепатита нет, в запущенных случаях возникает стремительное ухудшение состояния, нарастание асцита, желтухи, неспецифических желудочно-кишечных симптомов, потери веса, [анорексии](#).



© ПроБолезни. Все права защищены

Развитие цирроза и рака печени

У 10-15 % больных с хроническим вирусным гепатитом С возможно развитие аутоиммунных заболеваний, наиболее частыми из которых являются аутоиммунный гепатит (АИГ) и криоглобулинемия. АИГ — это иммуноопосредованное поражение печени. Внешне оно мало

отличается от проявлений гепатитов другой этиологии, но зачастую имеет более агрессивное течение и поддаётся терапии только длительными курсами иммуносупрессивных препаратов. **Криоглобулинемия** — накопление в малых и средних кровеносных сосудах специфических белков, которые вызывают затруднение в них тока крови и приводят к специфическим проявлениям.

Также определена связь гепатита С с развитием сахарного диабета, неходжкинской лимфомы и кожной порфирии Тарда [\[2\]](#)[\[8\]](#)[\[9\]](#)[\[10\]](#).

Диагностика гепатита С



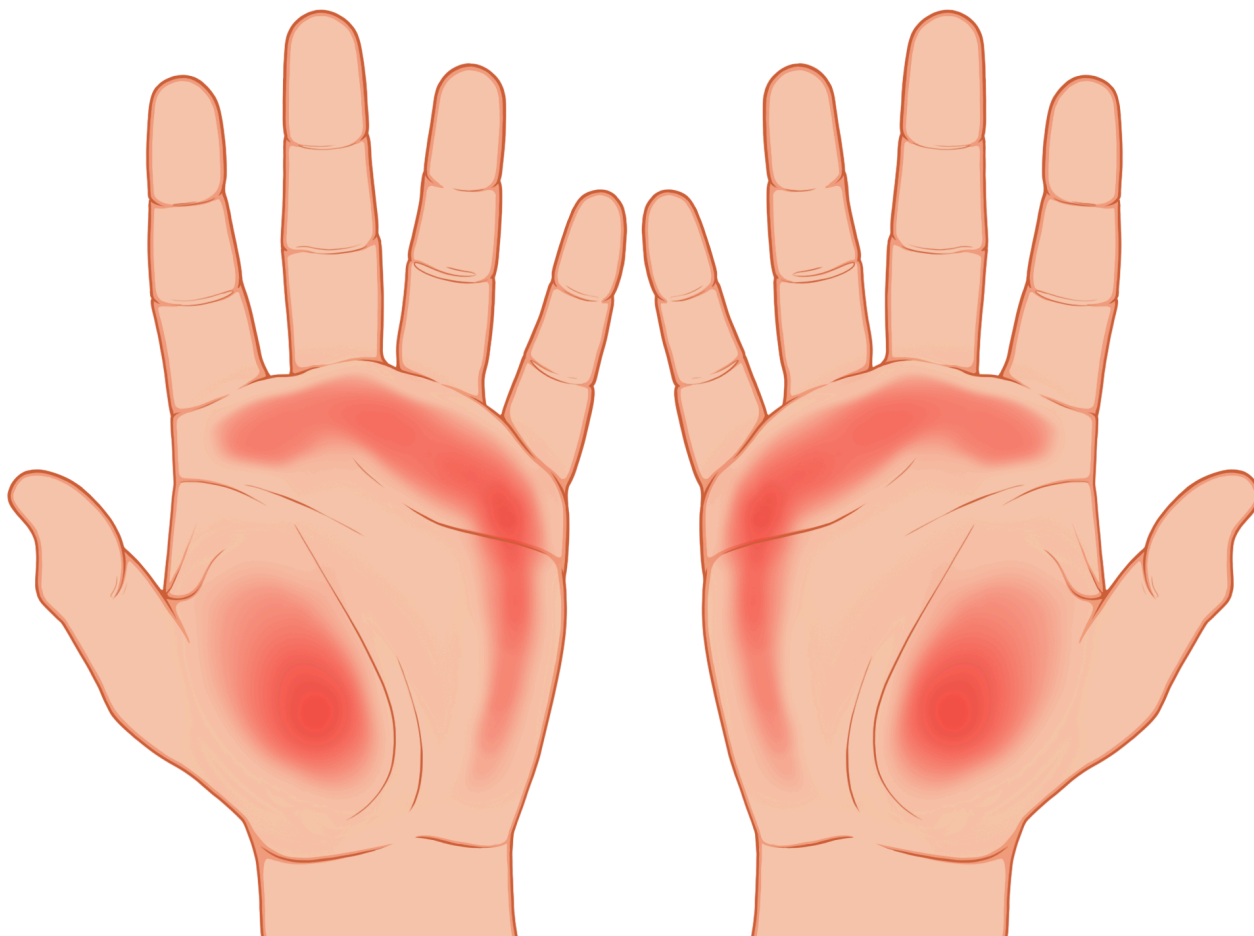
Следите за здоровьем с приложением МедТочка

Записывайтесь к врачам, ведите медкарту и показывайте её на приёме.

[Скачать приложение медточка](#)

Вариантов первичного выявления вируса и заболевания множество, однако чаще всего гепатит С выявляется в ходе планового обследования при сопутствующем заболевании (операции или госпитализации). Как правило, обнаруживают повышенный уровень АЛТ или антитела к гепатиту С (HCVAb). Это служит поводом для направления такого пациента к врачу-инфекционисту для углублённого обследования.

На приёме врач-инфекционист (гепатолог) **осматривает** пациента, в части случаев (в различных сочетаниях) выявляет характерное изменение цвета ладоней (печёночные ладони), увеличение размеров печени. В продвинутых случаях заболевания врач отмечает расширение вен области передней брюшной стенки ("голова медузы"), отёчность (в том числе асцит как причина увеличения размеров живота), [сосудистые звездочки](#) и др.



© ПроБолезни. Все права защищены

Печёночные ладони

Прохождение тестирования на гепатит С

При лабораторном обследовании в первую очередь должно быть назначено исследование на АЛТ, РНК вируса методом ПЦР качественно с чувствительностью 15-60 МЕ и антитела к вирусу гепатита С суммарные. При отрицательном результате ПЦР и положительном анализе на антитела диагноз гепатита С не подтверждается. Согласно действующему в РФ законодательству, такой человек должен быть поставлен на учёт к инфекционисту на срок 2 года с обязательным обследованием методом ПЦР раз в 6 месяцев. При отрицательном результате наблюдение прекращается с диагнозом паст-инфекция гепатита С (выздоровление). При положительном результате ПЦР происходит подтверждение диагноза — острый или хронический вирусный гепатит С — и назначается дополнительное обследование в целях уточнения текущего состояния. Необходимо помнить, что выявление суммарных антител в иммуноферментном анализе (ИФА) говорит лишь о прошлой встрече с инфекцией и не даёт практически никакой информации о наличии заболевания в текущий момент. Антитела могут сохраняться пожизненно.

Обязательно должны быть назначены следующие исследования:

1. Развернутый клинический анализ крови + СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Для гепатита С характерны: лейкопения (снижение количества лейкоцитов), лимфо- и моноцитоз (увеличение числа лимфоцитов и моноцитов), уменьшение СОЭ, тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов);
2. Биохимический анализ крови:
 - a. аланинаминотрансфераза (АЛТ) — возможен нормальный уровень или периодическое повышение;
 - b. аспартатаминотрансфераза (АСТ) — норма или повышение;
 - c. гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) — норма или повышение;

- d. щелочная фосфатаза (ЩФ) — повышение при ухудшении процесса;
 - e. общий билирубин — норма или повышение;
 - f. общий белок — снижение при нарушении функции печени;
 - g. протеинограмма — повышение гамма-глобулинов;
 - h. протромбиновый индекс (ПТИ) — снижение при прогрессировании процесса;
 - i. креатинин, амилаза, сахар.
3. **Онкомаркеры.** Альфафетопротеин — повышение при прогрессировании процесса и развитии рака печени.
 4. **Общий анализ мочи** — появление уробилина, белка.
 5. **УЗИ органов брюшной полости** — возможно увеличение размеров печени и селезёнки, изменение структуры печени, размера внутренних сосудов.
 6. **ФГДС** — исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Выявляется расширение вен пищевода при развитии портальной гипертензии — осложнение цирроза печени.
 7. **Фиброскан** — метод оценки фиброза печени, который позволяет определить тяжесть заболевания без биопсии (F0 – отсутствие фиброза, F4 — цирроз).
 8. **ПЦР на гепатите С** — качественный и при необходимости количественный тест.
 9. **Генотипирование** — определение генотипа вируса гепатита С.
 10. **Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С** (при неудаче в лечении препаратами прямого действия или высоком риске такой неудачи до лечения).
 11. **Анализ на маркеры сопутствующих вирусных гепатитов** (HbsAg, HbcorAb total, anti-Hbs).
 12. **Анализ на ВИЧ.**



При необходимости список исследований может расширяться. Стоит подчеркнуть, что грамотное назначение обследования и его интерпретация возможны исключительно врачом-инфекционистом (гепатологом). Врач назначит лишь необходимое, тем самым поможет пациенту сэкономить деньги, даст грамотную оценку полученных данных, что чрезвычайно важно в планировании дальнейшего лечения и его исхода [\[2\]\[5\]\[6\]\[9\]\[12\]](#).

Дифференциальная диагностика

- Вирусные и невирусные гепатиты другой этиологии. Связаны с путешествиями, любыми повреждениями кожи и слизистых, употреблением заражённых пищи и воды. Отличаются выраженностью симптоматики. Для уточнения диагноза проводятся специфические серологические тесты ИФА и ПЦР.
- Токсическое поражение печени. Связано с недавним значительным употреблением алкоголя или токсинов. Проводятся специфические серологические тесты ИФА и ПЦР, выявляется чрезмерное повышение ГГТ (фермент, маркер поражения печени).
- Паразитарные заболевания печени (например [описторхоз](#), [эхинококкоз](#)). Связаны с проживанием в эндемичном регионе, употреблением плохо приготовленной рыбы, контактом с собаками. Характеризуются выраженной эозинофилией (увеличением уровня эозинофилов) периферической крови. Проводятся специфические серологические тесты, выявление яиц паразитов, инструментальные исследования.
- Первичный или метастатический рак печени. Изучаются данные анамнеза о сопутствующих заболеваниях, учитываются результаты инструментальной и лабораторной диагностики [\[2\]\[4\]\[10\]\[11\]](#).

Надо ли проверяться на гепатит С здоровому человеку

Регулярное обследование на гепатит С при отсутствии симптомов следует проводить медработникам, пациентам отделений гемодиализа, частым посетителям стоматолога, больным хроническими заболеваниями с частыми парентеральными вмешательствами (внутривенно, подкожно и внутримышечно) и лицам, часто меняющим половых партнёров.

Лечение гепатита С

Основу любого лечебного воздействия составляет правильно подобранная диета. В отношении вируса гепатита С этот метод как никогда актуален, однако он зачастую игнорируется как пациентами, так и самими врачами.

Диета при гепатите С

Самое главное условие — полный отказ от алкоголя. Ничто так не вредит печени, как алкоголь. Именно он может стать тем фактором, который запускает цепь патологических реакций и переводит гепатит из вялотекущего процесса в высокоактивный, ускоряя наступление цирротической стадии гепатита. В отношении других продуктов питания и напитков следует соблюдать золотую середину: питание должно быть разнообразным, всего должно быть в меру, без злоупотреблений "тяжёлой" пищей (ограничение жирного, жареного, солёного, копчёного) с учётом отсутствия или наличия сопутствующих заболеваний.

Большое значение имеет поддержание разумной физической активности и контроль веса (индекс массы тела не должен превышать 25 кг/м²).

Какие врачи лечат гепатит С

Лечением гепатита С занимаются врачи-инфекционисты.

Медикаментозная терапия Гепатита С

Медикаментозное лечение гепатита С зависит от фазы развития заболевания, индивидуальных особенностей и возможностей организма. В остром периоде широко применяется инфузионная терапия (введение растворов) с привлечением различных дезинтоксикационных (очищение организма от вредных веществ) и питательных лечебных растворов.

Роль специфической противовирусной терапии острого гепатита С окончательно не решена и возможна лишь в индивидуальном порядке, например при угрозе хронизации или при фульминантном течении болезни (тяжёлом варианте воспалительно-некротического поражения печени). При невозможности радикального лечения гепатита С в хронической фазе вполне приемлема поддерживающая терапия так называемой группой гепатопротекторов (фосфолипиды, аминокислоты, антиоксиданты и др.). Данные средства не имеют чётко доказанной эффективности, однако широко применяются на практике и в некоторых случаях способны несколько задержать прогрессирование заболевания. Хороший эффект даёт нормализация функции ЖКТ и улучшение микрофлоры кишечника.

Попытки воздействия на вирус предпринимались с момента его открытия. Вначале это было изолированное применение препаратов интерферона короткого действия, затем комбинации интерферона короткого действия и рибавирина (препарата общевирусного действия). Их сменила комбинация интерферона пролонгированного действия и рибавирина.

К концу интерфероновой эпохи были достигнуты значительные успехи в процессе лечения и избавления человеческого организма от вируса гепатита С. Однако терапия была длительной, процент излечения достигал не более 70 % в среднем по генотипам, и курс лечения имел серьёзные побочные эффекты, иногда приводя к последствиям намного серьёзнее, чем сам гепатит С. Это обстоятельство дало толчок к разработке принципиально новых лекарственных средств, характеризующихся прямым противовирусным действием, сочетающих высокую эффективность (до 99 %), высокий профиль безопасности (минимальные побочные эффекты), простоту и удобство дозирования и небольшую длительность (2-3 месяца). В основу механизма действия легло подавление ключевых этапов размножения вируса, в первую очередь протеазы и полимеразы вируса гепатита С. Проведённые испытания препаратов показали высокие результаты, и, начиная с 2013 года, данная группа последних эффективных разработок с успехом применяется во всём мире. В некоторых странах одобрено лечение детей современными препаратами начиная с 3 лет (в зависимости от генотипа) с соответствующими взрослым показателями успеха.

Можно ли вылечить гепатит С полностью

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила гепатит С полностью излечимым заболеванием.

На 2020 год в мире доступны следующие виды и комбинации лекарственных препаратов прямого противовирусного действия для лечения гепатита С:

- Софосбувир.
- Даклатасвир.
- Элбасвир и Гразопревир.
- Глекапревир и Пибрентасвир.
- Ледипасвир и Софосбувир.
- Омбитасвир / Паритапревир / [Ритонавир](#).
- Омбитасвир / Паритапревир / Питонавир / Дасабувир.
- Симепревир.
- Софосбувир и Велпатасвир.
- Софосбувир / Велпатасвир / Воксилапревир (комбинация не зарегистрирована в РФ).

Как лечить гепатит С в домашних условиях

Назначение противовирусной терапии должно осуществляться врачом, хорошо ориентирующимся в множестве применяемых для терапии гепатита С лекарств, после изучения всех составляющих процесса, возможных противопоказаний, взаимодействий с уже принимаемыми препаратами, особенностей диеты и образа жизни [1][5][8][9]. Гепатит С — тяжёлое инфекционное заболевание, которое может привести к циррозу и раку печени, поэтому самолечение опасно для жизни.

Схемы лечения гепатита С в России

В России на сегодняшний день для лечения гепатита С используется преимущественно устаревшее лечение интерферонами (чаще бесплатно или со скидкой), в редких случаях — препаратами прямого противовирусного действия (чаще платно со скидкой).



Пусть о вашем здоровье позаботится врач

Найти врача на **продокторов**

Прогноз. Профилактика

Если лечение гепатита начать до того, как разовьётся цирроз печени, то прогноз будет благоприятным: как правило, наступает полное излечение. При запущенных стадиях (цирроз и рак печени) прогноз зависит от множества факторов, обычно при начальном циррозе больные при должном лечении могут жить дальше без каких-либо серьёзных проблем со здоровьем, при декомпенсированном процессе прогноз неблагоприятный.

Прогноз при отсутствии лечения гепатита С

В среднем без лечения при отсутствии пагубных привычек и здоровом образе жизни в течение 20 лет примерно у 10-20 % больных разовьются цирроз и рак печени, при регулярном злоупотреблении алкоголем, наркотиками и токсинами (в том числе лекарствами) доля таких тяжёлых осложнений составит до 30-40%.

Из-за повышенной мутационной способности вируса существует ряд технических сложностей в создании вакцины — на данный момент её не существует (ведутся разработки). Поэтому меры профилактики распространения вируса гепатита С направлены на разрывы механизмов и путей передачи вируса, санитарное информирование и обучение населения.

Первичная профилактика

1. Предупреждение возможности заражения в медицинских учреждениях:
 - a. гигиена и обработка рук, инструментария, использование перчаток;
 - b. тестирование донорской крови, плазмы и компонентов;
 - c. тестирование донорских органов;
 - d. надлежащее проведение медицинских инъекций;

- е. обучение медицинского персонала;
 - ф. обследование доноров, беременных, госпитализированных.
2. Предупреждение полового пути заражения
 - г. обучение правильному и своевременному использованию презервативов;
 - h. тестирование перед вступлением в брак.
 3. Выдача стерильного инструментария потребителям инъекционных наркотиков (не во всех странах).

Вторичная профилактика

1. Проведение противовирусной терапии (в идеале при выявлении заболевания, т. к. это предупреждает дальнейшее распространение инфекции).
2. Матерям с гепатитом С (если он не был пролечен до беременности) следует внимательно следить за состоянием целостности кожи сосков и рта ребёнка, при наличии повреждений необходимо прекращать грудное вскармливание на время до их заживления [\[2\]\[7\]\[9\]\[12\]](#).

Что делать, если член семьи болен гепатитом С

Самое важное, что следует сделать, чтобы предотвратить заражение вирусом — это избегать контакта с кровью инфицированного человека. Кровь может быть заразной, даже если она сухая. Надевайте перчатки, если вам нужно прикоснуться к использованным бинтам. После контакта с кровью тщательно вымойте руки, даже если вы были в перчатках.

Некоторые предметы личной гигиены могут иногда содержать небольшое количество крови. Не следует совместно использовать зубную щётку, бритву или маникюрные ножницы.

Деятельность ВОЗ

В мае 2016 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую «Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016–2021 гг. Главной целью стратегии является снижение к 2030 г. числа новых случаев инфицирования вирусным гепатитом на 90 % и смертности от вирусного гепатита на 65 %. Для реализации этой стратегии ВОЗ занимается повышением осведомлённости о заболевании и его профилактике и расширяет охват услугами по скринингу, оказанию помощи и лечению гепатита С [\[13\]](#).

Источники

1. Бацких С.Н. Безинтерфероновая терапия хронического гепатита «С»: смена препаратов или новая парадигма лечения? // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2014. — № 4. — С. 23-31.
2. Вирусные гепатиты в Российской Федерации: Справочник / под ред. Г. Г. Онищенко, А.Б. Жебуна. СПб: НИИЭМ им. Пастера. — 2013.
3. Горячева Л.Г., Рогозина Н.В., Мамаева В.А., Иванова В.В Перинатальный вирусный гепатит «С» и возможности его лечения // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2014. — Т. 18, № 3. — С. 4-8.
4. Учайкин В. Ф. Инфекционная гепатология: рук. / В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В. Смирнов. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 608 с.
5. HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C / The American Association for the Study of Liver Diseases and the Infectious Diseases Society of America Present. — 2017.
6. [Thad Wilkins, Jennifer K. Malcolm, Dimple Raina, Robert R. Schade Hepatitis C: diagnosis and treatment // Am Fam Physician. — 2010; 81\(11\): 1351-1357.](#)

7. Гепатит С. Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения // ВОЗ. — 2017
8. Hepatitis C // National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. — 2020.
9. Hepatitis C Questions and Answers for Health Professionals // Centers for Disease Control and Prevention. — 2020.
10. Вирусные гепатиты в Российской Федерации / под ред. В.И.Покровского, А.Б.Жебруна. — Спб.: НИИЭМ им. Пастера, 2013.
11. ФГБУ НИИДИ ФМБА России. Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям больным острым вирусным гепатитом С. — 2015. — 31 с.
12. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С.
13. Гепатит С // ВОЗ, 2020.
14. Zink C. How to Identify and Treat a Hepatitis Rash // Verywell Health. — 2022.

Клинические случаи «Гепатит С»

1. [Случай неожиданной находки хронического гепатита С при подготовке к операции](#)
2. [Бессимптомный гепатит С: случай успешного лечения препаратами прямого противовирусного действия](#)

проблемы

Компания



Наши продукты



Условия использования



Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 89287 от 09.04.2025 г. Учредитель - ООО «МЕДРОКЕТ» ОГРН 1122311003760. Адрес редакции: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 182, офис 87. Телефон: 8 (495) 374-93-56. Email: help@medrocket.ru. Главный редактор - С.Р. Федосов.

Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения администрации.

Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.